TEMA 15



LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1- Evolución de la Protección Social en España.	
2.- Situación actual de los sistemas de Protección Social en España.	
2.1.- Educación. 2.2.- Sanidad. 2.3.- Pensiones. 2.4.- Servicios Sociales.	
3.- El Sistema de Protección Social tras el covid-19.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

0.- INTRODUCCIÓN.

Analizar la historia y la evolución de la Protección Social en nuestro país es una tarea fundamental para entender el hoy y el mañana del actual sistema de Servicios Sociales, una de las piedras angulares de nuestro sistema de bienestar. Las formas históricas en las que se ha asentado la Protección Social nacen de un contexto complejo. La situación económica e histórica, la visión del hombre y de la sociedad, la religión … han sido el caldo de cultivo en el que se han ido desarrollando estas propuestas.

1.- EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA.

Un análisis riguroso de la protección social exige repasar la evolución de los diversos sistemas de la Acción Social. Hay que entender que el actual sistema de Servicios Sociales tiene una **raíz histórica**, y que éstos son –también- una **construcción histórica**. Las actuales formas de asistencia son un modelo más, entre los que se han desarrollado en el tiempo, para hacer frente a la realidad de las necesidades sociales.

No nos encontramos ante una historia lineal, sino ante una evolución irregular, con avances y retrocesos. En su sentido más genérico podemos definir la **Acción Social** como "**Todo esfuerzo consciente, organizado y dirigido, individual o colectivo, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla**" (Ander-Egg).

La protección de las personas socialmente excluidas ha revestido a lo largo de la historia formas muy variadas. El análisis se va a concretar a las **principales formas históricas** en que ha sido ejercida la protección social al necesitado, que en síntesis convencional pueden resumirse en las siguientes:

- Caridad.
- Beneficencia.
- Seguros Sociales / Asistencia Social Pública.
- Servicios Sociales.

La **Acción Social** ha existido siempre, desde las primeras civilizaciones. Lo que ha hecho ha sido sistematizarse en torno a unos principios ideológicos, un sistema organizativo, unos recursos que han evolucionado a lo largo del tiempo.

El primero de estos principios será la fe cristiana, la atención al pobre –como hijo de Dios- será el principal argumento de la **etapa de la Caridad**. Esta etapa en España, a diferencia de otros países europeos que inician más tempranamente procesos de secularización, se extenderá hasta principios del siglo XIX. Es importante diferenciar dos grandes momentos: **la Edad Media y el Renacimiento**.

Durante la **Edad Media** toda la vida gira en torno a la religión. En esta sociedad teocéntrica la ayuda al pobre es parte del camino de la salvación: los ricos se salvarán mediante la limosna, los pobres mediante la resignación. El nacimiento de las ciudades hará que poco a poco la pobreza se vaya convirtiendo en un problema social al que se tratará de dar respuesta.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Tres serán los elementos que se irán modificando entre la Edad Media y el Renacimiento: por una parte **el paso de una caridad religiosa a una caridad laica**, por otra **el paso de la indeterminación de la asistencia** –centrada en los Hospitales que abren los monasterios- **a la concreción y diferenciación de establecimientos** –diferenciando, por ejemplo, entre pobres y enfermos- y, un paso fundamental, **de la no discusión sobre la falsa pobreza a la necesidad de distinguir entre los verdaderos y los falsos pobres.**

Será un autor español, **Juan Luís Vives**, el que inicie este proceso de cambio en el Renacimiento con su obra "**Del Socorro de los Pobres**" en 1.526. Su reflexión no se aparta de los planteamientos cristianos, pero, reconocido como precursor del Trabajo Social, propone que los municipios tengan el protagonismo de la asistencia a los pobres. La racionalización de la lucha contra la pobreza será su línea de actuación en el contexto protestante de la ciudad de Brujas, proponiendo medidas absolutamente novedosas: los censos de pobres en función de los diferentes tipos de pobreza, la diversificación de actuaciones en medidas preventivas, curativas o asistenciales, la intervención del municipio …

Este debate vendrá a España de la mano de dos autores, a raíz de la publicación en la ciudad de Zamora en **1.540** de las primeras normas que tratan de ordenar la lucha contra la pobreza. Por una parte, **Domingo de Soto** trata de volver a las ideas más tradicionales: la acción social depende de la caridad, no se puede limitar la mendicidad, no podemos diferenciar entre falsos y verdaderos pobres … por otra parte, **Juan de Robles** (o **Juan de Medina**) propone, en la línea de Vives, un sistema organizativo que permita que la ayuda se destine exclusivamente a los verdaderos pobres, limitando la mendicidad y ofreciendo subsidios a los pobres hasta que éstos pudieran ser suficientes con su propio trabajo.

Miguel de Giginta, canónigo catalán compaginó la promoción y difusión de sus ideas en numerosas obras –"Remedio de Pobres", "Exhortación a la compasión", "Atalaya de Caridad" …- con el diseño –incluso arquitectónico-, impulso y gestión de su propuesta de innovación básica para la solución de la mendicidad: las **Casas de Misericordia**. En su obra trata de dar respuesta a la grave situación de la economía española (cosechas deficitarias, paro, carestía de precios …) y a la ausencia de organización y deficiente gestión de las instituciones de caridad –se abrían centros de forma indiscriminada, pero sin contar con los recursos suficientes, el control público era ineficaz …-.

Pérez de Herrera, publica en 1.598 el "Amparo de Pobres" ("Discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos"). Sus planteamientos parten de la distinción entre verdaderos y falsos pobres –a los que habría que castigar severamente-. La ociosidad y la vida alejada de la práctica religiosa, la simulación de enfermedades, el maltrato a los niños … son consecuencias de la práctica libre de la mendicidad. Propone la ordenación de la mendicidad a través de dos vías simultáneas: los **Albergues de Pobres y la reglamentación de la mendicidad callejera.**

En la etapa de la Caridad tendremos que esperar hasta el **Renacimiento** para encontrarnos las primeras manifestaciones jurídicas, ya que en la **Edad Media** los **Fueros** o colecciones de leyes apuntaban de forma secundaria y, desde una perspectiva religiosa, a los deberes cristianos de atender al pobre. La citada normativa de Zamora, de Carlos I, será el primer intento en nuestro país de disponer medidas administrativas eficaces en la acción social: las cédulas de pedir que se concedían a los verdaderos pobres les habilitaban para mendigar, se establecen hospitales, casas de misericordia, hospicios … en un intento de diversificación de los recursos, se propone la ayuda domiciliaria para los pobres vergonzantes …

A mediados del siglo XIX llegan a España los ideales liberales de la Revolución Francesa y los planteamientos filosóficos ilustrados de la vecina Francia. Europa inicia el siglo de la razón, la superación de las ideas tradicionales de la superstición y de la religión … y una de sus consecuencias es que serán los poderes públicos los que asuman el protagonismo en la lucha contra la pobreza. En nuestro país la religión seguirá teniendo protagonismo con momentos de conflicto, como los producidos por las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Podemos señalar como principales autores de esta época a Jerónimo Feijoo y a Pedro Rodríguez de Campomanes. **Jerónimo Feijoo** (1.676-1.764), benedictino y considerado precursor del movimiento ilustrado. Llama a los mendigos ociosos "viles vagabundos" y "zánganos inútiles". Propone la creación de hospicios para cubrir las necesidades básicas de los pobres inválidos y dar empleo a los pobres válidos en oficios públicos.

Pedro Rodríguez de Campomanes (1.723-1.803) reitera que la sociedad debe atender a los verdaderos pobres mediante la limosna. Afirma que más importante que la limosna es dar al pobre educación y trabajo. Plantea la necesidad de ofrecer un subsidio transitorio a los indigentes hasta que encuentren trabajo. Impulsará la creación de las **Sociedades Económicas de Amigos del País**, entidades que agrupan a nobles, intelectuales y clérigos de espíritu reformista para impulsar cambios colectivos.

La principal característica de esta segunda etapa -**la beneficencia-** en nuestro país será la aprobación de dos Leyes de Beneficencia. La primera de ellas, la **Ley de Beneficencia de 1.822** se plantea en el contexto liberal heredado por la Constitución de Cádiz de 1.812, la conocida como "la Pepa" con planteamientos descentralizadores –**la Beneficencia se organiza desde los municipios**- que no volveremos a encontrar en nuestro país hasta el último tercio del siglo XX. La segunda, la **Ley de Beneficencia de 1.849**, realizará una propuesta de carácter centralizador: la Beneficencia es una responsabilidad del Estado que se desarrollará a través del Ministerio de la Gobernación.

- La beneficencia tiene una finalidad pública, ya que los establecimientos de beneficencia son públicos.
- La organización administrativa es pública. La dirección suprema corresponde al Gobierno, así como la creación y supresión de centros, y la aprobación de los reglamentos de los establecimientos. Su gestión se encomienda al Ministerio de la Gobernación. Frente al criterio descentralizador de la Ley de 1.822 emerge ahora un principio de centralización de la actividad benéfica.
- La beneficencia constituye un sistema de protección social, a través de la coordinación de los distintos órganos administrativos que se crean. Se establecen la Junta General, las Juntas Provinciales y las Juntas Municipales de Beneficencia. Están compuestas por personal civil y eclesiástico.
- De la Junta General dependen los Establecimientos Generales, que se destinan a satisfacer las necesidades permanentes (locos, sordo-mudos, ciegos, impedidos, decrépitos).
- De las Juntas Provinciales dependen los Establecimientos Provinciales, que atienden a las personas con enfermedades comunes, los pobres incapaces de un trabajo, las casas de misericordia, las de maternidad y expósitos, las de huérfanos y desamparados.
- De las Juntas Municipales dependen los Establecimientos Municipales, destinadas a socorrer las enfermedades accidentales, a transportar a los pobres a establecimientos provinciales o generales, a atención domiciliaria.
- La beneficencia se financia de un fondo patrimonial común compuesto por bienes de naturaleza pública –presupuestos general, provincial y municipal- y de naturaleza privada –fundaciones, limosnas-.
- Los establecimientos se someten a un régimen presupuestario y contable común. Los presupuestos son examinados por la Junta correspondiente, el déficit se cubre con presupuestos públicos.
- La beneficencia ofrece prestaciones gratuitas a los pobres, aunque hay algunas excepciones (ayudas de familias, ayudas de los socorros otorgados ...).
- El ingreso en los establecimientos es voluntario, no puede recluirse a personas por motivos disciplinarios o correccionales.
- La Ley y el Reglamento no afirman que los pobres tengan derecho subjetivo a la asistencia, pero a la vez, los establecimientos benéficos están obligados a recibir a los pobres.
- Se delimitan las competencias municipales en materia de beneficencia. Su función fundamental reside en el socorro y la hospitalidad domiciliaria.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

- Es una ley respetuosa con los establecimientos privados, que están sujetos a la inspección y control administrativo y contable.

La Beneficencia se constituye como un **sistema público** que se coordinará –siguiendo a la Ley de 1.849- a través de la Junta General, las Juntas Provinciales y las Juntas Municipales, formadas todas ellas por personal civil y eclesiástico. De cada una de estas Juntas dependerán diversos tipos de establecimientos que son regulados en el **Reglamento de 1.852**, señalándose, a modo de ejemplo, los hospitales de impedidos y decrépitos, los hospicios y casas de misericordia, las casas de huérfanos y expósitos o, germen de recursos más modernos, las Cajas de Ahorro, los Montes de Piedad y los Pósitos.

Los establecimientos se citan en diferentes normas (especialmente en el Reglamento de 1.852). Los principales establecimientos son los siguientes:

- Hospitales de enfermos.
- Hospitales de convalecientes.
- Hospitales de impedidos y decrépitos.
- Casas de dementes.
- Hospicios y casas de misericordia → albergue de pobres e impedidos, incapaces de realizar un trabajo personal.
- Casas de huérfanos → recogen a los niños huérfanos pobres que no son cuidados por ninguna familia.
- Casas de maternidad → para mujeres solteras embarazadas.
- Casas de expósitos → para la atención de los niños abandonados.
- Asilos de párvulos → para niños que no pueden ser atendidos porque sus padres están trabajando.
- Casas de socorro → para la cura ambulatoria de enfermedades accidentales.
- Refugios o albergues → para el acogimiento provisional mientras se traslada al indigente al hospicio.
- Casas de arrepentidas → para las mujeres que han abandonado la prostitución.
- Casas de lavado y baños de pobres → para la limpieza y prevención de enfermedades contagiosas.
- Establecimientos especializados para sordo-mudos y ciegos.
- Pósitos → instituciones donde podían guardarse instrumentos de primera necesidad para su propio remedio en situaciones de carencia.
- Montes de Piedad → Instituciones que prestaban dinero a los necesitados bajo prenda de alhajas, muebles o ropas, a bajo interés.
- Cajas de Ahorro → Instituciones que reciben dinero de las personas y lo devuelven con un interés añadido.

El principio del siglo XX va a traer a nuestro país la llegada de la tercera etapa de la Protección Social. Este período se va a iniciar con una ruptura en la homogeneidad de los sistemas de Protección Social, ya que vamos a diferenciar entre los **Seguros Sociales y la Asistencia Social**.

El sistema de los **Seguros Sociales** nació en la Alemania del tercer tercio del siglo XIX con los Seguros Sociales del canciller Bismarck con los que trata de neutralizar las protestas de la clase obrera. Los Seguros Sociales, novedad fundamental, no se basan en el requisito de necesidad, sino en la **idea de previsión**: los trabajadores prevén que ante determinados riesgos (enfermedad, desempleo, jubilación …) sea el Estado el que se haga cargo –gracias a la cotización previa- de la cobertura de las necesidades que tenían aseguradas a través del trabajo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Estos planteamientos llegan a nuestro país con la creación en **1.903 del Instituto de Reformas Sociales** y, especialmente, en **1.908 con la puesta en marcha del Instituto Nacional de Previsión**. A partir de este momento, y a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, se irán aprobando una serie de Seguros Sociales que cubren riesgos concretos a los trabajadores –maternidad, accidentes laborales, enfermedad, vejez …- culminando este proceso con la unificación de todos ellos a finales de los años 50 y la aprobación de las primeras Leyes de Seguridad Social en la década de los 60.

La Protección Social será complementada con la **Asistencia Social Pública** a aquellas personas que se encontraban en **situación de indigencia** El inicio del sistema asistencial quedará truncado en España con la Guerra Civil y la aparición en la posguerra de un sistema al que algunos autores han llamado como de **Beneficencia Pública**, caracterizado por la presencia de organismos como Auxilio Social o la Sección Femenina con una perspectiva en la que los planteamientos del régimen franquista, del catolicismo y de la beneficencia se mezclaban en un intento de dar respuesta a las necesidades de la España de la posguerra.

Hasta los años sesenta no volvemos a encontrarnos en nuestro país con la noción de asistencia social, como sistema complementario de la Seguridad Social, que da respuesta a aquellos que están en situación de necesidad mediante prestaciones gratuitas y financiadas por el Estado.

Como muestra de la superación clara de los planteamientos benéficos en los 60 se creará el **Fondo Nacional de Asistencia Social,** que ofrecerá prestaciones a ancianos, enfermos, infancia o disminuidos desamparados, siendo sustituido a mediados de los 70 por el Instituto Nacional de Asistencia Social.

El final del anterior régimen y la llegada de la democracia iba a ser un momento excepcional para la revisión de nuestro sistema de Protección, un sistema claramente deficitario con una orientación, como hemos señalado, benéfica, compasiva, desvinculada de la intervención comunitaria o generalista, centrada en determinados colectivos y con claro predominio del sector privado.

Desde finales de los 70 se van a producir **reformas en las estructuras administrativas** –asumiendo las competencias sociales nuevos Ministerios-, **reformas políticas** –con la desaparición de las organizaciones franquistas-, un incremento de los Servicios Sociales Públicos –a través del recién creado Inserso- y, sobre todo, una **instauración paulatina del sistema autonómico** –con las políticas de transferencias a las Comunidades Autónomas-.

La **Constitución de 1.978**, como han reconocido todos los autores, será el punto definitivo de inflexión para el nacimiento en España del sistema moderno de Servicios Sociales. Los **principios constitucionales** recogidos en el **art. 1** –España es un Estado Social-, el **art. 9.2**. señalado igualmente en la actual Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (11/2.003) con el compromiso por la plenitud y participación de los ciudadanos en todos los ámbitos vitales, el **art. 14** reconociendo la igualdad … señalan un compromiso inequívoco que será asumido por las Comunidades Autónomas en virtud de la obligación establecida en el **art. 148.1.20.**

La aprobación del **Plan Concertado en el año 1.988** –al que Madrid se suma un año más tarde- supondrá colocar como administración protagonista de la protección social de los ciudadanos a la administración que tradicionalmente se ha reconocido como más cercana a sus intereses: la Administración Local.

A partir de este momento la aprobación de **las Leyes de Servicios Sociales de primera generación** en los años 80 permitirán el nacimiento de un sistema con vocación de universalidad que, como señalan las **Leyes de segunda generación** (la Ley 11/2.003 en el caso de la Comunidad de Madrid) harán ya una apuesta clara por unos Servicios Sociales de calidad orientados a los ciudadanos, con el fin de garantizar su plenitud y calidad de vida.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA.

El modelo social que sucedió a la Segunda Guerra Mundial implicó un salto cualitativo en la forma de entender la idea de "igualdad" que hasta ese momento habían tenido las democracias liberales, y el papel del Estado en relación a ella. Se pasó entonces de una concepción estrictamente formalista, basada en el principio de **igualdad ante la ley**, a otra de carácter material que buscaba la reducción de las desigualdades por la vía de la intervención pública. El concepto de **igualdad material** se convirtió así en el eje de la acción pública y del debate político en torno a cómo procurarla.

La idea que subyace en el paradigma social inaugurado entonces consistía en que **el crecimiento económico y la cohesión social deben ser un binomio indisociable**, algo así como un concepto complejo que se retroalimenta constantemente. La raíz de esta apuesta por instrumentos públicos de redistribución está en la firme creencia de que la violencia extrema desencadenada (por dos veces) desde Europa durante la primera mitad del siglo XX tuvo en la desigualdad social y económica, si no su germen directo, el caldo de cultivo en el que creció y se multiplicó. Se constató entonces que los instrumentos tradicionales que se habían conformado para responder a aquel fenómeno no eran suficientes: básicamente un Sistema de Seguridad Social de aseguramiento que protegía apenas unas pocas contingencias (casi exclusivamente el accidente de trabajo y la vejez) de los trabajadores industriales, y postergaba al resto de riesgos y personas al cuidado de la beneficencia.

El Estado Social, que hoy conocemos comúnmente con la etiqueta de "**Estado de Bienestar**", nació de esta manera como la fórmula de la que se dotó la acción pública para conseguir un objetivo muy concreto: lograr la **integración social de las personas** que viven en un lugar dado. Tal integración se consigue a través de la **cohesión social**, reduciendo las desigualdades con medidas que ayuden a la redistribución de la riqueza.

Se superaba así la formulación previa de Estado asistencial que sólo actúa sobre las bolsas de pobreza más extrema desde la beneficencia, y ahora pretende una actuación mucho más ambiciosa, interviniendo de forma integral sobre todas las capas de población y en las principales esferas económicas y sociales, a través de derechos sociales y económicos. El Estado de Bienestar, además de utilizar instituciones concretas de actuación, inaugura una estrategia de acción consistente en impregnar de este objetivo la orientación de todas las políticas públicas que acomete (empleo, educación, protección social…).

En este marco, el sistema de protección social, y las figuras de actuación de las que se dota, adquiere una función estratégica (aunque no exclusiva). Hemos de tener presente que la **distribución de la riqueza** se da así en un doble plano. El primario, a través del trabajo y el salario. Y el secundario, a través de la fiscalidad y el gasto social, donde se ubica el sistema de protección social. Los mejores resultados se consiguen cuando ambos niveles se dan de forma sucesiva. Pero sería un error entenderlos como niveles alternativos, obviando el papel que tiene el trabajo y el salario, y articulando las medidas de redistribución de la riqueza exclusivamente desde el nivel secundario, sólo con medidas de protección social.

Podemos definir la **protección social** como **la cobertura solidaria de las necesidades básicas**. Esto es, cuando dichas necesidades son cubiertas por unidades distintas de los hogares (en este caso el Estado) y su financiación se realiza de modo que el reparto de cargas, si lo hay, sea solidario y no estrictamente proporcional al riesgo (esto es, sin coste para el beneficiario o con un coste inferior al de mercado, de manera que se garantice el acceso a toda la población). Las prestaciones pueden reconocerse en forma de prestación económica o mediante una prestación en especie o servicio.

Los riesgos o necesidades que dan origen a las prestaciones sociales más comúnmente reconocidos por la literatura científica son los de enfermedad, invalidez, incapacidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, vejez, supervivencia, maternidad, cargas familiares, fomento del empleo, desempleo, vivienda, educación, y la pobreza. Todos ellos cabrían a su vez, compilarse en cuatro grandes ámbitos de protección: **la sanidad, el desempleo, las pensiones y los servicios sociales.**

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2.1.- EDUCACIÓN.

La educación era, sin duda, una de las prioridades al abordar el cambio democrático en este país. Una primera consecuencia directamente extraída de los **Pactos de la Moncloa**, fue el compromiso de llevar a cabo un programa extraordinario de creación de centros públicos y la elaboración de un estatuto de centros subvencionados para mejorar la calidad. Distintas leyes y normativas han ido modificando el sistema educativo haciendo realidad la **gratuidad de la enseñanza obligatoria y la total escolarización**. Ampliar la formación de los jóvenes y retrasar la entrada en el mercado de trabajo han sido también dos objetivos a conseguir. Para ello se llevó a cabo la aprobación en 1983 de la Ley de Reforma Universitaria y de la **Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE),** con el objetivo de desarrollar, el precepto constitucional de la autonomía universitaria y efectuar una distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las propias universidades, además de posibilitar la reforma de la organización y funcionamiento de la universidad para adecuarla al proceso de modernización y democratización de la sociedad española.

En 1990 se produce la aprobación de la **Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)**, que derogó la Ley General de Educación de 1970, y adapta el sistema educativo en España a los cambios sustanciales producidos en la sociedad a partir de la democracia. Los puntos más importantes y novedosos de esta ley son. 1) Ampliación de la educación básica hasta los 16 años en condiciones de obligatoriedad y gratuidad. 2) Una reordenación del sistema con el establecimiento de las etapas de educación infantil, educación primara, educación secundaria, formación profesional 3) La reforma en profundidad de la formación profesional. Una de sus líneas directrices es también el desarrollo de acciones para las personas y colectivos en situaciones desfavorables, en especial la educación compensatoria y la educación de personas adultas.

La LOGSE fue sustituida por **la Ley Orgánica de la Educación (LOE)**, aprobada en 2006. En 2.013 se va a modificar esta Ley mediante la **LOMCE o Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.** Sus principales objetivos son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales y mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. Recientemente, la LOMLOE integra los principios del respeto a los derechos de la infancia, la educación inclusiva, la igualdad de género y la orientación educativa y profesional.

La educación es uno de los componentes de la actuación de los poderes públicos con **mayor potencial redistributivo** y de mayor importancia estratégica para la sociedad en su conjunto, tanto por sus beneficios económicos como sociales. El nivel educativo, además de ser un elemento imprescindible en la **igualdad de oportunidades**, constituye una de las claves tanto de la **empleabilidad** de la persona como de su **nivel de ingresos laborales**. La educación es un recurso clave en la estructura social y en las oportunidades vitales de las personas, de tal forma que los procesos de exclusión social no son ajenos a las carencias educativas.

Por tanto, la educación es una variable que puede o bien reproducir la pobreza, o bien revertirla, y de ahí, la necesidad de garantizar el acceso y permanencia en la educación a los menores más vulnerables pues, en caso contrario, se estará perpetuando su situación de exclusión social.

Junto a la **gratuidad de la enseñanza básica obligatoria** (de los 6 a los 16 años), la **política de becas y ayudas al estudio** es una de las medidas que más puede contribuir a superar las dificultades materiales de acceso a la educación por los alumnos pertenecientes a hogares en riesgo de pobreza, garantizando el ejercicio del derecho fundamental a la educación.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

En efecto, pese a la gratuidad del acceso a la enseñanza básica, es decir, la educación primaria y la ESO, la escolarización conlleva una serie de costes asociados, como los libros de texto y el material escolar, o el transporte, que para algunas familias suponen un coste demasiado gravoso para su nivel ingresos. En este sentido, hay que señalar que los años de la crisis han puesto de relieve la necesidad de comedor escolar gratuito o a precio asequible para un sector de la población más vulnerable económicamente.

La educación infantil tiene carácter voluntario y no tiene carácter gratuito en el primer ciclo (de 0 a 3 años). Sin embargo, una **escolarización de calidad y accesible en educación infantil** surte efectos beneficiosos en los niños, tiende a compensar desde edades tempranas las desventajas ligadas a un entorno socioeconómico adverso, contribuye a la reducción del abandono escolar temprano, especialmente en los grupos socialmente más desfavorecidos y repercute en el aumento de la actividad laboral de las madres en un contexto en que la baja intensidad laboral de los hogares aparece muy ligada al problema de la pobreza infantil.

Por otro lado, hay que señalar que los **niveles post-obligatorios no universitarios**, es decir, en el bachillerato, y en los ciclos de formación profesional de grado medio y superior, ni son gratuitos ni obligatorios, por lo que las becas no solo tienen la función de garantizar la igualdad en el acceso, sino también de romper la relación entre el abandono temprano de los estudios y el bajo nivel de renta, así como de compensar el coste oportunidad entre seguir escolarizado y trabajar. A este respecto conviene señalar que los ciclos de formación profesional básica, introducidos por la Ley Orgánica para la Mejora de la calidad educativa (LOMCE), y que sustituyen a los programas de cualificación profesional inicial (PCPI), son de oferta obligatoria y carácter gratuito.

El **riesgo de pobreza es muy superior entre las personas con nivel educativo bajo**, por lo que las **actuaciones contra el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación** revisten particular importancia a la hora de prevenir las situaciones de carencia de recursos. Asimismo, para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza y avanzar hacia una educación que garantice el éxito escolar de todo el alumnado, son necesarias medidas de apoyo que permitan **corregir la desventaja que supone partir de un contexto educativo y socioeconómico desfavorecido**. **Las medidas de compensación de desigualdades en educación y de atención a la diversidad** tienen como objetivo asegurar la permanencia en el sistema educativo en condiciones de igualdad, así como **mejorar el rendimiento escolar y luchar contra el fracaso escolar**.

En España se vienen desarrollando dos programas de cooperación territorial de compensación educativa; el **Plan para la reducción del abandono escolar temprano**, así como el **Plan de refuerzo, orientación y apoyo (PROA)**, dirigido a centros con estudiantes de origen socioeconómico bajo, en educación primaria y secundaria.

Con el fin de aumentar significativamente la escolarización en educación secundaria post-obligatoria, es necesario **mejorar el rendimiento en la ESO**, incrementar las tasas de acceso y titulación en bachillerato y en los ciclos formativos de grado medio (CFGM), además de fomentar el retorno a la educación reglada de los alumnos que la hayan abandonado.

Por otro lado, para **reducir el abandono de los estudios profesionales**, algunos elementos que pueden ayudar a la retención de los estudiantes en la FP desde el sistema educativo podrían ser: un registro individual de los alumnos para monitorizar su escolaridad, establecer programas puente destinados a reducir el abandono temprano, ofrecer vías alternativas para los jóvenes que abandonan prematuramente la FP o corren ese riesgo, fomentar el aprendizaje basado en el trabajo, e incluso ofrecer incentivos financieros a los estudiantes para que permanezcan en la FP o vincular esos incentivos a la asistencia y al rendimiento de los alumnos.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

En un plano más amplio sería conveniente **fomentar la participación activa de las empresas**, mediante los incentivos empresariales idóneos, en aras de propiciar una mayor colaboración entre los centros de formación profesional y las empresas.

Asimismo, sería beneficioso que los aprendizajes adquiridos por las diferentes vías no solo estén encaminados a la obtención de cualificaciones incluidas en el marco nacional de cualificaciones, sino que se adopte un enfoque de calidad que incluya indicadores de rendimiento claros, y una mayor celeridad en la convalidación del aprendizaje formal e informal.

Las competencias estatales en materia de educación son desarrolladas desde el **Ministerio de Educación y Formación Profesional**, que asume la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo. En la Comunidad de Madrid han sido asumidas por la **Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía** (aun no se ha aprobado el Decreto que regula su estructura y funciones).

2.2.- SANIDAD.

En el apartado sanitario es necesaria una breve referencia predemocrática para destacar que desde el año 1.967 la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se había desarrollado y se fue consolidando la organización sanitaria.

En el año 1978 se crea el **Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)** y posteriormente se aprueba la **Ley General de Sanidad** que da paso a la creación de **un Sistema Nacional de Salud**. En el diseño de este sistema se optó por el modelo de reforma ofrecido por la OMS y la UNICEF, entre cuyas características se señalaba la necesidad de reforzar el nivel de la atención primaria con el fin de racionalizar el gasto sanitario.

La **Ley General de Sanidad** fue aprobada en 1986, unificando la atención primaria, la especializada y la farmacéutica. Preveía su financiación pública a través de ingresos del Estado y cotizaciones de la Seguridad social, destacando el hecho de que consagra una **cobertura universal** a toda la población. Proclama el derecho al **libre ejercicio de las profesiones sanitarias**, así como la libertad de empresa en el sector sanitario.

En 1989 se aprobó el llamado "**Decreto de universalización**" que propició la incorporación de las personas atendidas previamente por la beneficencia pública previa al Sistema Nacional de Salud. Todo este proceso de expansión del sistema sanitario se vio favorecido por la bonanza económica de la segunda mitad de los años ochenta.

En 1995, con el Real Decreto sobre la **ordenación de las prestaciones**, se elabora un catálogo o lista de los servicios autorizados y legalmente exigibles por el ciudadano y de aquellas otras prestaciones que quedan excluidas por no ser consideradas como "esenciales" para conservar la vida. En la actualidad, a través de un proceso que ha llevado varios años, ya se ha procedido al **traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas**, de manera que pueden regular su Servicio de Salud, pero la Ley General de Sanidad determina las líneas básicas.

La **Ley 14/1986**, de 25 de abril, general de Sanidad, sobre la que se asienta la creación del **Sistema Nacional de Salud**, recoge explícitamente como finalidad de las políticas de gasto sanitario la **corrección de las desigualdades sanitarias, así como la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos** en todo el territorio. Entre los principales determinantes de la salud, junto a la propia herencia genética y calidad del entorno ambiental, destacan los denominados **determinantes sociales**, es decir, el nivel socioeconómico de las personas y los estilos de vida desplegados en función del estatus económico, educativo y social. La interrelación entre salud/pobreza y el papel del sistema sanitario se manifiesta claramente en la medida en que las situaciones de precariedad económica influyen en la salud, del mismo modo que los problemas de salud pueden acarrear importantes pérdidas de ingresos que, en casos extremos, lleven a la pobreza. El papel del sistema sanitario es fundamental a la hora de aminorar estos riesgos y contribuir a superar buena parte de las desigualdades en salud, independientemente de su origen.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Los diferentes estudios suelen constatar que, a igual nivel de necesidad, las diferencias de renta no dan lugar en España a diferencias en el acceso a la atención sanitaria. No obstante, mientras que la equidad parece clara en el caso de la atención primaria, el componente redistributivo falla en el acceso a algunos servicios de atención especializada, como los odontológicos, con cobertura limitada por parte del sistema público y en los que el nivel de renta marca las posibilidades de su provisión privada.

El esfuerzo en el cuidado de la salud de los colectivos con mayores dificultades para alcanzar estos servicios es una herramienta clave, ya que, entre otros aspectos, puede reforzar su inclusión activa en el mercado de trabajo, y asegurar el bienestar de la población infantil y de mayor edad, dado que se trata de las personas más vulnerables desde el punto de vista sanitario.

La gran mayoría de los españoles tiene reconocido el derecho a la asistencia sanitaria pública. No obstante, no se ha de obviar que el estado de la salud puede encontrarse, en determinados supuestos, vinculado al estatus socioeconómico. En este sentido, constituye un ejemplo ilustrativo la atención bucodental que, a pesar de su importancia para el mantenimiento de un buen estado de salud general, está recogida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud de una forma muy limitada, ya que excluye los tratamientos más habituales. En este sentido, también cabría señalar las prestaciones relacionadas con el servicio de oftalmología, donde existe una carencia en la cobertura (gafas y lentes), representando una dificultad para las familias sin recursos económicos. También cabe apuntar que las consecuencias de algunas disfuncionalidades en la provisión de los servicios, como las listas de espera para recibir atención diagnóstica o quirúrgica, pueden incidir en mayor medida en la población con niveles socioeconómicos bajos, que difícilmente cuenta con alternativas en el circuito privado de atención a la salud.

Por otra parte, más allá de los obstáculos socioeconómicos que se han señalado, es necesario **incrementar la eficacia de los programas de salud pública**, particularmente importantes entre la población con niveles socioeconómicos bajos, más afectados por patologías relacionadas con los hábitos de vida. Numerosos estudios señalan, por ejemplo, que los patrones de alimentación más saludables exhibidos por los distintos grupos revelan un mayor consumo de frutas y verduras frescas en los segmentos de más cualificación y una frecuencia más alta de consumo de refrescos azucarados, dulces y carnes en los segmentos menos cualificados. De ahí que, como en la mayoría de los países desarrollados, la pobreza en España no esté ligada a un problema tanto de desnutrición como de **malnutrición**, lo que conduce a graves problemas de salud crónicos, incluyendo la obesidad y todas sus complicaciones derivadas. La situación general de España es especialmente grave en lo que se refiere al **sobrepeso y obesidad de la población**. Se trata un problema contemplado por la estrategia NAOS, que requiere profundizar en un enfoque que integre la salud pública en otras políticas, especialmente la educativa.

La **gratuidad de los medicamentos** constituye uno de los factores que más puede incidir en el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la atención sanitaria a los grupos más vulnerables de la sociedad. La prestación farmacéutica, a diferencia del resto de los servicios sanitarios, conlleva para el ciudadano que este financie un determinado porcentaje del precio del medicamento, el denominado copago farmacéutico. El copago farmacéutico se aplica a la prestación farmacéutica ambulatoria, es decir, aquella dispensada al paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria, a través de oficinas o servicios de farmacia.

Algunos gobiernos autonómicos han aprobado en los últimos años medidas destinadas a combatir la exclusión social, que también contemplan ayudas en el ámbito sanitario y socio sanitario de muy distinto alcance. En algunos casos se centran en complementar o incrementar las ayudas ya existentes en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, mientras que en otras incluso, con diferentes requisitos, amplían el alcance de la protección, incluyendo a colectivos excluidos, como los extranjeros en situación administrativa irregular.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Se mantiene como objetivo alcanzar un **pacto por la sanidad y los servicios sociales que garantice estos servicios bajo los principios de equidad y calidad de la atención**. Bajo este objetivo el citado plan planteó tres tipos de actuaciones: establecer los cauces adecuados entre los diferentes niveles de gobierno para alcanzar dicho pacto que garantice la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos; garantizar el acceso a una atención integral, de calidad, en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional y siempre en el marco de un modelo flexible y sostenible, y potenciar el abordaje intersectorial de la salud teniendo en cuenta el enfoque de los determinantes sociales de la salud y facilitar que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial de salud considerando las distintas necesidades de cada una de ellas.

Corresponde al **Ministerio de Sanidad**, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. En la Comunidad de Madrid será la **Consejería de Sanidad** la entidad responsable para desarrollar y garantizar las prestaciones sanitarias.

2.3.- PENSIONES.

De manera muy general, podemos acudir a la definición que lo identifica como el sistema que trata de **garantizar un nivel de ingresos a todas aquellas personas que no pueden mantener una vinculación con el mercado laboral**, especialmente por razón de edad. En el caso español, este sistema se apoya, -a partir del **Documento Base sobre la Reforma de la Seguridad Social de 1985**- en tres pilares: a) El **nivel contributivo de la Seguridad Social**; b) El **nivel no contributivo** c) Los **planes privados de pensiones**.

El primero de los pilares, se financia a través de las **cotizaciones sociales realizadas por empresarios y trabajadores** y cubre el derecho a **pensiones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y a favor de familiares.** El alcance de la pensión viene determinado por la vida laboral activa.

El segundo de los pilares, garantiza un nivel de ingresos mínimos de aquellas personas que han tenido una **vinculación débil o inexistente con el mercado laboral** y demuestran **insuficiencia de recursos**. Su financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y son gestionadas por las Comunidades Autónomas. Contemplan el **derecho a pensiones de jubilación e invalidez, así como prestaciones económicas por hijo a cargo**.

Por último, los planes privados de pensiones son contratos que se establecen con una entidad financiera, mediante los cuales se van a percibir, en la edad de jubilación, determinadas prestaciones en función de las aportaciones que hayan realizado y sirven como **complemento del sistema público**.

2.4.- SERVICIOS SOCIALES.

En 1.978 España firmó la **Carta Social Europea**, con la que asumía la obligación de dotarse de un sistema de servicios sociales. En abril de 1985, la **Ley de Bases de Régimen Local**, en su artículo 26.1.c obligaba a los municipios mayores de 20.000 habitantes a prestar servicios sociales a su población. En 1978 se crea el **Instituto Nacional de los Servicios Sociales de la Seguridad Social (INSERSO),** como gestor de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de seguridad social e integra el antiguo Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos (SEREM). Una de las actuaciones más destacadas de este organismo fue la aprobación de la **Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI),** con la que se ponía punto final al hegemónico sistema contributivo de participación en la sanidad y en las pensiones. Prácticamente desde su creación el INSERSO, comienza a transferir sus competencias a las Comunidades Autónomas, con lo que se van modificando, constantemente, sus atribuciones.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El **desarrollo administrativo** del sistema se lleva a cabo a través de tres niveles:

1) **Administración Central**, con la intervención de distintos organismos que pertenecen a diferentes ministerios (Trabajo y Seguridad Social, Interior, Sanidad, Justicia …) según la característica del servicio y del colectivo al que se dirigen

2) **Administraciones Autonómicas** que han ido asumiendo las competencias que contemplaba la Constitución y promulgando leyes específicas y

3) **Administraciones Locales**, con una población superior a 20.000 habitantes, según estableció em su anterior redacción la Ley de Bases de Régimen Local.

Los servicios sociales constituyen el ámbito institucional en el que se gestiona el problema de la pobreza y la exclusión social, pues su nivel de atención primaria constituye **la puerta de acceso al resto de los dispositivos de naturaleza asistencial**. Al margen de la propia gestión de las prestaciones económicas (las PNCs, por el IMSERSO, y las RMI, por los servicios sociales autonómicos) a los servicios sociales en este primer nivel les corresponde la tarea de **detección, acogida, recogida de demandas y evaluación social de cada persona/familia** en riesgo de vulnerabilidad social, además de la función fundamental de **acompañamiento y la inserción social de las personas en estas situaciones**. Además, los servicios especializados dan respuestas a situaciones concretas en diversos ámbitos (centros de menores, casas refugio de mujeres víctimas de violencia de género, centros de acogida de refugiados, etc.).

La configuración actual del sector de servicios sociales deriva de la confluencia de los distintos niveles competenciales así como de la manera en que se ha desarrollado la vertiente asistencial de la protección social en España. Por lo que afecta a los servicios sociales, este proceso se ha desarrollado en España de **forma heterogénea y desigual**; por un lado, las comunidades autónomas asumieron la competencia en servicios sociales a través de sus Estatutos de Autonomía, en virtud del artículo 148 de la CE que recoge la posibilidad de que estas asuman las competencias en materia de asistencia social, y por otro, las entidades locales, en aplicación de las competencias que les otorgaba la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de régimen local65, desarrollaron su propio cuadro de servicios sociales en función de las necesidades detectadas en su población.

De esta forma, los servicios sociales se han estructurado en dos niveles: **el nivel local o de atención primaria**, que se configura como el primer contacto de la población con el sistema, basado en el **principio de proximidad** para garantizar la rapidez en la detección de problemas, y un segundo nivel, de **ámbito autonómico**, **de atención especializada para colectivos específicos.**

Este sistema ha venido desarrollándose a través de la **aprobación de las distintas leyes de servicios sociales** que, si bien mantienen semejanzas importantes y se estructuraron en un momento inicial siguiendo un patrón similar, su evolución y reforma, a través de unas segundas e incluso terceras leyes de servicios sociales, ha derivado en una disparidad de sistemas en cada una de las comunidades autónomas. Este sistema se ha ido complementando con otras **normas autonómicas que abordan aspectos específicos en función de determinados colectivos** (infancia, familia, discapacidad…) o ámbitos (rentas mínimas, vivienda…). A su vez, las comunidades autónomas y los entes locales, como ya se ha visto, siguiendo la senda marcada por el PNAIN, han desarrollado sus propios **planes de inclusión social** adecuando el tratamiento y contenido a las características de su ámbito territorial de actuación y en función de los problemas a los que se enfrenta su población.

Asimismo, multitud de **leyes generales y sectoriales de ámbito estatal** han incidido en la regulación autonómica de los servicios sociales. Este impacto puede verse en el ámbito de la dependencia (Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), en la protección a la infancia (Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del menor o Ley 54/2007 de Adopción internacional), la discapacidad (Real Decreto legislativo 1/2013, texto refundido de la Ley general de los Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social) o la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de género).

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Tampoco se debe olvidar la importancia de las pensiones no contributivas, que, si bien son competencia Estatal por encontrarse dentro del sistema de la Seguridad Social, son gestionadas por las comunidades autónomas y deben coordinarse con las distintas prestaciones económicas que estas han desarrollado en el ámbito del sistema de garantía de rentas.

Dentro de estas, es importante destacar la LAPAD que inició un proceso modernizador en el ámbito de la protección social al reconocer a los ciudadanos en situación de dependencia un derecho subjetivo y universal. Este modelo de orientación universalista y garantista de derechos, ha iniciado un proceso de reconocimiento y garantía del derecho a los servicios sociales que se ha incorporado en las recientes leyes autonómicas de servicios sociales.

Esta nueva batería de normas persigue como objetivo el **reconocimiento de un derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales**, si bien en algunas de ellas este derecho solo se configura como exigible para algunos servicios y prestaciones esenciales o garantizadas, estableciéndose el resto de prestaciones como no garantizadas o de acceso condicional. Sin embargo, los servicios y prestaciones concretas, así como sus requisitos de acceso, quedan pendientes de desarrollo, en mayor o menor medida, a través de la **regulación reglamentaria del catálogo o cartera de prestaciones**. Dentro de las novedades introducidas, también cabe destacar la **ampliación de los derechos y deberes de los usuarios**, la obligatoriedad de una prestación de servicios basada en **sistemas de calidad**, el desarrollo de la regulación de la prestación de estos por la **iniciativa privada** y la necesidad de **garantizar la sostenibilidad del sistema**, que incorpora derechos exigibles, a través de una ordenación más exhaustiva de los mecanismos de financiación.

El desarrollo desigual y la dispersión de regulaciones caracterizan el panorama en esta materia, así como **el impacto que la crisis económica** haya podido tener en las previsiones establecidas por estas nuevas leyes, que en muchos casos han visto limitadas sus previsiones por legislaciones posteriores. En este sentido, la garantía de unos mínimos en todo el territorio del Estado se alcanzó, en el ámbito de los servicios sociales municipales, con el **Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales**. Este instrumento de cooperación entre los tres niveles territoriales, que no se encuentra elevado a rango legal y que se ha visto debilitado a partir de la crisis económica por una progresiva disminución de las aportaciones al mismo, sobre todo de la aportación financiera del Estado, persigue asegurar la financiación y asistencia técnica de estos servicios, garantizando el acceso a todos los ciudadanos a unas prestaciones básicas.

Asimismo, la necesidad de introducir cierta coherencia y consenso en materia de servicios sociales impulsó la elaboración del **Catálogo de Referencia de Servicios Sociales** [1] aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Este catálogo parte del concepto de "sistema público de servicios sociales" como un conjunto de servicios y prestaciones que, insertándose con otros elementos de protección social, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas, la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, y la prevención y eliminación de las causas que conducen a la exclusión social.

[1] **Prestaciones de servicios**. Actuaciones que realizan los equipos técnicos orientadas a atender las necesidades sociales y favorecer la inserción social de los ciudadanos y ciudadanas, familias y grupos de población:
— Información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración.
— Autonomía personal, atención en el domicilio y respiro familiar.
— Intervención y apoyo familiar.
— Intervención y protección de menores.
— Atención residencial.
— Prevención de la pobreza e inclusión social.
— Protección jurídica.
Prestaciones económicas. Aportaciones económicas, de carácter periódico o pago único, ofertadas para garantizar mínimos de subsistencia o situaciones de emergencia sobrevenidas a los ciudadanos:
— Renta mínima de inserción.
— Ayuda para víctimas de violencia de género.
— Prestaciones económicas para personas en situación de dependencia.
— Otras prestaciones económicas.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

Este Catálogo recoge las prestaciones de referencia a las que podría acceder una persona en el territorio estatal, con independencia de la entidad y forma de provisión y del sistema de protección social al que pertenezca. Sin embargo, más allá del avance que supone la definición de ese conjunto de servicios y prestaciones, el catálogo debería servir para impulsar el seguimiento de los derechos que recoge y las actuaciones abordadas en este terreno por las comunidades autónomas.

En este contexto, se llevó a cabo la **reforma del sistema competencial municipal** a través de la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración (LRSAL), que tiene como uno de sus principales objetivos evitar las duplicidades existentes en materia de competencias municipales y garantizar su financiación. Esta reordenación competencial afecta de forma directa a los servicios sociales municipales. Con la entrada en vigor de esta reforma, los municipios dejan de ejercer como competencia propia la "prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social", limitándose está a la "**evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**". Con esta articulación, la LRSAL —en su redacción inicial— excluyó los servicios sociales del elenco de materias dentro de las que, en todo caso, las leyes autonómicas deben atribuir competencias propias a los entes locales para garantizar la autonomía municipal. En su disposición transitoria segunda (DT 2.ª), estableció la obligación a las comunidades autónomas de asumir la titularidad de estas competencias con fecha de 31 de diciembre de 2015, limitando las alternativas de las comunidades autónomas a la delegación de esta competencia en los entes locales, en virtud del mecanismo establecido que exige que vaya acompañada de la correspondiente financiación, siendo nula sin dotación presupuestaria.

La orientación de los servicios sociales, ya muy centrada desde sus comienzos en el **ámbito de la tercera edad,** requirió dedicar a ese terreno muchos más recursos y esfuerzos con el despliegue que supuso la puesta en marcha del SAAD y la configuración de la atención a la dependencia como un derecho subjetivo. Lógicamente, ello supuso también indirectamente una apuesta por la prevención y lucha contra la pobreza ligada a la vejez y la dependencia, si bien otras áreas de la intervención social más conectadas específicamente con las políticas de lucha contra la exclusión social pudieron verse afectadas por este protagonismo de la atención a la dependencia.

La **llegada de la crisis**, con el abrupto aumento de las necesidades sociales simultáneo a la disminución de presupuestos y personal en servicios sociales (este último decreció un 30 por 100 entre 2007 y 2014), repercutió en profundizar en un desequilibrio más, el de la transferencia al tercer sector de acción social de buena parte de los cometidos en el terreno de la inserción social, a salvo de la gestión y concesión de las rentas mínimas. Ello explicaría el descenso de los usuarios en el ámbito del Plan Concertado que, en el 99,8 por 100 de los casos lo fueron de centros y servicios sociales y, en mucha menor medida, usuarios de albergues y centros de acogida.

Los **entes locales** han venido desarrollando su actuación en el ámbito de los servicios sociales en desarrollo de las disposiciones de la Ley de Bases de régimen local que establecía la competencia de los municipios en la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, obligatoria para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y la competencia de las diputaciones en la coordinación de estos servicios municipales, la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, y la prestación de estos servicios en el ámbito supramunicipal o supracomarcal.

De esta forma, estos servicios municipales se configuran como **un elemento clave del sistema de servicios sociales, detectando y atendiendo las necesidades de su población, bajo un enfoque comunitario, a través de actuaciones de carácter preventivo y de atención a las personas con mayores dificultades de inclusión y participación social, en base a los principios de proximidad y accesibilidad**.

Sin embargo, en la práctica, su desarrollo ha sido más bien de carácter reactivo a los problemas de los ciudadanos lo cual, si bien ha supuesto uno de los éxitos de la provisión local de servicios sociales, al confluir con una falta de delimitación clara de las competencias, la dispersión geográfica, los problemas de financiación y la heterogeneidad de tamaño de estos entes han desembocado en un **desarrollo desigual del sistema de prestaciones** en el conjunto del territorio estatal.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Pese a las importantes carencias de información sobre las actuaciones concretas en el ámbito de los servicios sociales, es evidente que esta compleja organización competencial apunta a problemas de descoordinación territorial, duplicidad de servicios o prestaciones, lagunas, solapamientos y problemas de financiación. Aunque parte del éxito del sistema se basa en la atención primaria a nivel local, aprovechando la cercanía y proximidad al ciudadano, una efectiva cooperación entre Administraciones es determinante para lograr la eficiencia en el desarrollo del sistema de servicios sociales.

La **colaboración del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales** ha sido una constante desde la aparición de estos últimos en el sistema de protección social español, mucho más tardía que la de muchas organizaciones de carácter no lucrativo que tradicionalmente venían actuando en este ámbito. La aparición de nuevos riesgos sociales y de situaciones de emergencia han aumentado las actuaciones del sector en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y han supuesto la consolidación de las organizaciones del tercer sector de acción social (en adelante, TSAS) como agentes colaboradores de las Administraciones públicas en este ámbito. Esta colaboración se puede observar, por ejemplo, en algunos de los programas de interés general subvencionados con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como con cargo a otros programas y subvenciones destinados a organizaciones del TSAS. Asimismo, cabe mencionar las actuaciones de este sector en la lucha contra la exclusión social a través de la gestión de bolsas de empleo y la intermediación para colectivos en desventaja o socialmente estigmatizados, así como los programas de inserción sociolaboral dirigidos a personas con especiales dificultades de integración e inserción y financiados con cargo a Programas Operativos de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo o la gestión del programa operativo de ayuda alimentaria del Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas (2014- 2020), por citar solamente algunos ejemplos.

En materia de **inmigración y asilo** cabe reseñar los programas llevados a cabo por ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Cruz Roja Española con cargo a las Subvenciones del Programa de Protección Internacional para la acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, la asistencia sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en España, así como la atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Durante los últimos años de crisis los servicios sociales han estado especialmente sometidos a la doble presión derivada del crecimiento de la demanda, por el aumento de situaciones de vulnerabilidad social como consecuencia de la crisis, junto con una importante restricción de recursos derivada de la aplicación de las medidas de consolidación fiscal. La insuficiencia de los dispositivos de los servicios sociales para dar respuesta al crecimiento de las situaciones de vulnerabilidad económica y social ha provocado en los últimos años un desplazamiento de la demanda hacia entidades sin ánimo de lucro en el ámbito del tercer sector de acción social.

En 2015 se aprobó la norma que, por primera vez, regula la definición, el marco de actuación y las medidas de fomento del denominado tercer sector de acción social –**Ley 4/2.015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de la acción social-**. Prácticamente de manera simultánea en el tiempo se tramitó y aprobó la primera norma de carácter estatal que regula el voluntariado **–Ley 45/2.015, del 14 de octubre, de Voluntariado-** . La aprobación de ambas normas formaba parte de los compromisos contenidos en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016, con el objetivo de fomentar la movilización y la participación de la sociedad civil.

La Ley del Tercer sector de acción social (TSAS) estableció los principios rectores de la actuación de las entidades que integran este sector, regulando su ámbito de actuación, la participación institucional y estableciendo una serie de medidas para su fomento. Por su parte, la nueva Ley de Voluntariado, define los principios comunes al voluntariado organizado, establece los derechos y deberes inherentes a esta figura y amplía el concepto de persona voluntaria más allá de lo puramente asistencial, dando cabida a otros ámbitos de la participación ciudadana complemento de la actividad pública, como la educación o el deporte.

Estas entidades centran su actuación mayoritariamente en los campos de acción social, atención socio-sanitaria e integración e inserción, si bien en los últimos años, y con motivo del cambio en la realidad social, los dos primeros han visto disminuida su importancia relativa, aumentando de forma significativa la intervención de estas entidades en integración e inserción y en vivienda.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3.- EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL TRAS EL COVID-19.

La **pandemia de COVID-19** ha supuesto una llamada de atención que ha alertado a la comunidad mundial y a los responsables de políticas nacionales acerca de la urgencia de acelerar los progresos en el establecimiento de sistemas de protección social. Es necesario aplicar una serie de medidas para dar una respuesta de emergencia adecuada y desarrollar una **estrategia a más largo plazo que contribuya a fortalecer los sistemas de protección social y la preparación a las crisis en los países en desarrollo**:

- Garantizar el **acceso a la atención sanitaria de calidad**, movilizando fondos públicos adicionales para aumentar los presupuestos en el marco de la respuesta de emergencia, y salvaguardar y ampliar la cobertura de los mecanismos de protección social de la salud durante y después de las crisis.
- Aumentar la **seguridad de los ingresos** mediante transferencias en efectivo, incrementando los niveles de prestaciones y ampliando la cobertura mediante programas nuevos o en vigor, adaptando las condiciones para recibir prestaciones, las obligaciones y los mecanismos de ejecución, y asegurando que, cuando sea necesario, las transferencias de efectivo humanitarias complementen y refuercen aún más los sistemas de protección social nacionales.
- Proteger a los **trabajadores de la economía informal** mediante el diseño de políticas innovadoras para llegar a ellos con rapidez, combinando los regímenes contributivos y no contributivos y, a más largo plazo, facilitar su transición a la economía formal.
- Asegurar la **protección de los ingresos y los puestos de trabajo** y promover sistemas de protección contra el desempleo y otros mecanismos para ayudar a las empresas a retener a los trabajadores y proporcionar un apoyo a los ingresos para los trabajadores desempleados, así como adaptar los programas públicos de empleo al contexto de la pandemia.
- Coordinar más sistemáticamente las **políticas de empleo y de protección social** para promover una recuperación sostenible.
- Movilizar recursos a nivel nacional y mundial sobre la base de la solidaridad, y estudiar diversas opciones con objeto de sostener y aumentar los esfuerzos después de la crisis para asegurar la **financiación sostenible de sistemas de protección social** basados en los derechos.

A pesar de los enormes esfuerzos realizados por los responsables de la formulación de políticas y las instituciones de seguridad social, la crisis también ha puesto de manifiesto las deficiencias existentes en los sistemas de protección social de cada país. Se han adoptado muchas medidas temporales para subsanar estas deficiencias durante la crisis, pero estos remedios provisionales requieren soluciones a largo plazo. Si bien las experiencias y las lecciones aprendidas durante la crisis relativas a la cobertura del sector informal, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de plataformas serán valiosas en este sentido, la solución no puede consistir simplemente en prolongar las medidas temporales en los próximos años. Por el contrario, las soluciones a largo plazo deben responder a las necesidades actuales de los diferentes grupos, proporcionar una financiación sostenible y una inversión adecuada en las capacidades que permiten aplicar estas medidas.

El documento conjunto de la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social), la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) propone cuatro vías para construir sistemas de protección social sólidos y resilientes para todos en el futuro y contribuir así a una recuperación inclusiva.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

a) Garantizar una cobertura universal que proporcione protección a los trabajadores sea cual sea la modalidad de empleo.

En consonancia con la visión de la cobertura universal, es necesario fortalecer los sistemas de protección social y adaptarlos para cubrir adecuadamente a los trabajadores que ejercen todo tipo de empleo, incluidos los trabajadores de la economía informal, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que ejercen nuevas formas de trabajo. Los regímenes de seguro social contributivos son la principal herramienta para alcanzar este objetivo, pero, en función de las necesidades, deberán completarse con regímenes financiados por medio de los ingresos fiscales para llegar a una financiación mixta sostenible y equitativa.

Los esfuerzos para extender el seguro social también son un medio para lograr el objetivo de promover la transición de la economía informal a la economía formal. Las deficiencias de la protección social son más evidentes en el caso de los trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores de la economía informal, que, a su vez, han sido los más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. La formalización del empleo es fundamental para lograr la protección social para todos.

b) Garantizar prestaciones y servicios suficientes para responder a las necesidades de la población.

Los sistemas de protección social deben evolucionar constantemente para mantener su capacidad de brindar de manera efectiva las prestaciones y los servicios que las personas y las familias necesitan para gestionar los riesgos en el mundo de hoy y de mañana. Para ello, es necesario aumentar la capacidad de resiliencia para hacer frente a crisis económicas imprevistas y otras perturbaciones, garantizar un complemento de ingresos accesible para todos, servicios sociales eficientes y de alta calidad, y hacer especial hincapié en las políticas activas del mercado de trabajo y de desarrollo de competencias.

c) Garantizar la sostenibilidad y la equidad en la financiación de sistemas de protección social basados en los derechos de la ciudadanía.

Las consideraciones relativas a la financiación sostenible deben ocupar un lugar central en las estrategias encaminadas a reforzar la protección social del futuro. El gasto de estabilización coyuntural durante la crisis ha provocado un aumento de la presión fiscal. Al mismo tiempo, el reconocimiento de la protección social como inversión en capital humano, estabilidad económica, cohesión social y bienestar individual exige un compromiso de apoyo continuo a las medidas de estabilización coyuntural mientras sea necesario. No obstante, se debe garantizar el equilibrio entre el gasto social y los ingresos para financiarlo, y definir estrategias que permitan colmar las lagunas de financiación.

d) Mejorar la capacidad de suministro para garantizar la continuidad de los servicios e incrementar la resiliencia.

Como lo recalcó específicamente la AISS, el fortalecimiento de la protección social en pro de una recuperación inclusiva se basa en la mejora de la capacidad de suministro para garantizar la continuidad de los servicios de seguridad social e incrementar la resiliencia. El desarrollo de una

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

capacidad institucional apropiada es un prerrequisito para que los regímenes de protección social efectivos se extiendan a todos los sectores de la población y un activo estratégico para la resiliencia nacional en tiempos de crisis.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados